

17 - 04- Les borrélioses - Pr. IHBIBANE

(0:07 - 0:35)

Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours sur les borélioses. L'agent pathogène borélie, ce sont des bactéries spirochettes, mobiles, extracellulaires, transmises par les arthropodes, qui sont responsables de fièvres récurrentes et de maladies de Lyme. Pour les fièvres récurrentes, on cite la fièvre récurrente à poux et la fièvre récurrente à tiques.

(0:37 - 1:08)

Dans les fièvres récurrentes, comme ce que nous avons dit, il y a la fièvre récurrente à poux, dont l'agent pathogène est le borélie recurrentis, transmise par les poux, et la fièvre récurrente à tiques, dont on peut trouver plusieurs types de borélie, le borélie dutoni, borélie hispanica, borélie parvum, borélie venezuelensis, transmises par les tiques. Les fièvres récurrentes à poux. Sur le plan clinique, l'incubation est de 2 à 8 jours.

(1:08 - 1:21)

Le début est généralement brusque, avec une fièvre supérieure ou égale à 40°C. Des algues diffusent, avec injection conjonctivale. A la phase d'état, on aura une succession des phases fébriles et des phases d'apexie.

(1:21 - 1:37)

Au cours de la première phase, la fièvre est en plateau. Présence d'un syndrome algique avec troubles digestifs, une splénomégalie à l'examen clinique, et parfois hépatomégalie et présence d'un nictère. Au septième jour, régression des signes généraux et apexie pendant une semaine.

(1:38 - 1:50)

Au quatorzième jour, récurrence fébrile et réapparition des signes généraux. Ceci va durer 3 à 5 jours, puis obtention de l'apexie. Et il faut dire qu'il n'y a le plus souvent que de récurrence.

(1:52 - 2:09)

Les fièvres récurrentes à tiques. Sur le plan clinique, le tableau clinique est similaire à celui de la fièvre récurrente à poux. Cependant, les récurrences et les périodes d'apexie sont plus nombreuses et plus courtes.

(2:11 - 2:23)

Voici un tableau comparatif entre la fièvre récurrente à poux et la fièvre récurrente à tiques. On remarque que la période d'incubation est la même, il est de 2 à 12 jours. La durée de fièvre de

rémission est la plus courte dans la fièvre récurrente à tiques.

(2:24 - 2:50)

Le nombre de rechutes est le plus important dans la fièvre récurrente à tiques, il peut aller jusqu'à 10. La possibilité de réaction de Jari-Sheikh Zemmer dans la fièvre récurrente à poux est plus sévère alors qu'il est légère dans la fièvre récurrente à tiques. Le taux de mortalité est le plus important dans la fièvre récurrente à poux, il peut aller jusqu'à 40% alors qu'il est moins de 10% dans la fièvre récurrente à tiques.

(2:50 - 3:11)

Pour les complications majeures, on peut observer dans la fièvre récurrente à poux des complications à type d'hépatite, myocardite, méningite, choc et hémorragie. Ces complications peuvent être aussi observées dans la fièvre récurrente à tiques, mais moins sévères. Ce sont essentiellement des complications neurologiques qui peuvent être observées lors des rechutes.

(3:14 - 3:32)

Pour le traitement des borélioses, il est basé sur un traitement curatif et un traitement préventif. Pour le traitement curatif, les antibiotiques qui peuvent être utilisés sont les cyclines, l'érythromycine, la pénicilline G et l'iphenicolée. La durée de traitement est de 5 à 10 jours.

(3:32 - 3:53)

Pour le traitement préventif, dans le cadre des fièvres récurrentes à poux, c'est l'utilisation des insecticides, l'hygiène corporelle et l'hygiène vestimentaire. Pour les fièvres récurrentes à tiques, c'est les répulsifs et les insecticides. On va voir maintenant la maladie de l'ail.

(3:54 - 4:20)

Plusieurs types de borélias sont responsables de la maladie de l'ail. Borélias burgdorferi, borélias garnii, borélias afzelii et d'autres types de borélias. Vous voyez ici des photos de la tique responsable de la transmission de la bactérie à l'homme après piqûre.

(4:21 - 4:36)

Voici un schéma qui vous montre le cycle de transmission de la bactérie. On voit sur le schéma que l'homme est un hôte accidentel. Une question très importante.

(4:36 - 5:02)

Sur quels éléments cliniques et épidémiologiques faut-il évoquer le diagnostic de la boréliose de l'ail? Le diagnostic est évoqué devant la notion d'exposition à piqûre de tiques avec présence de manifestation clinique. Au stade primaire, on remarque la présence d'un héritaire migrant. C'est

une macule hémithématique annulaire à croissance centrifuge.

(5:04 - 5:19)

Une photo qui nous montre la présence de la tique sur la peau après piqure. Sur le plan clinique, pour la maladie de l'ail, on identifie trois phases. La phase primaire, la phase secondaire et une phase tertiaire.

(5:21 - 5:34)

Le premier stade, c'est l'infection précoce localisée avec présence d'un héritaire migrant. Des symptômes généraux à type de céphalée, myalgie et fatigue. Le deuxième stade, infection disséminée précoce.

(5:35 - 5:47)

Des lésions annulaires secondaires, un lymphocytome cutané bénin. Méningite, paralysie faciale, radiculonevrite. Douleurs migrantes et transitoires au niveau des os, des muscles, des articulations et des tendons.

(5:47 - 6:05)

Des arthrites brèves, cardite avec possibilité d'un bloc oriculo-ventriculaire et d'insuffisance cardiaque. Conjonctivite, hépatite, orchite, ongue, toux. Au cours du troisième stade, c'est l'infection tardive persistante avec acrodermite chronique atrophique, morphée.

(6:06 - 6:26)

Encéphalomyélite chronique, paraparesie, polyneuropathie axonale, démence. Arthrite prolongée et chronique, périostite, kératite et rétinite. Voici un tableau qui résume aussi les manifestations cliniques de la maladie de Lyme.

(6:29 - 6:47)

Voici des photos qui vous montrent des manifestations cliniques de la borreliose. On voit ici l'héritaire migrant. Voici d'autres photos sur les manifestations cliniques de la maladie de Lyme.

(6:51 - 7:05)

Le diagnostic est basé sur la notion d'exposition à piqures de tiques avec présence de manifestations cliniques. La détection d'anticorps par dépistage par méthode ELISA. La confirmation par le Western Blot.

(7:06 - 7:37)

Les autres moyens diagnostiques, c'est la mise en évidence de la bactérie par culture, la PCR,

dans des laboratoires spécialisés et aussi à l'histologie. Pour le traitement, au cours de la phase primaire, le traitement est basé sur la moxiline à la dose de 3 g par jour pendant 14 jours. Ou la doxycycline à la dose de 200 mg par jour pendant 14 à 21 jours.

(7:38 - 7:56)

Au cours de la phase secondaire et la phase tertiaire, en cas de paralysie faciale isolée, le traitement est basé sur la moxiline à la dose de 3 g par jour. Ou la doxycycline à la dose de 200 mg par jour. Ou la ceftriaxone à la dose de 2 g en intraveineux pendant 14 à 21 jours.

(7:56 - 8:21)

En cas de méningite, le traitement est basé sur la ceftriaxone, 2 g en intraveineux pendant 21 à 28 jours. En cas d'arthrite aiguë, le traitement est basé sur la doxycycline à la dose de 200 mg par jour pendant 21 à 28 jours. En cas d'arthrite récidivante ou chronique, le traitement est basé sur la doxycycline à la dose de 200 mg par jour pendant 30 à 90 jours.

(8:22 - 8:42)

Ou la ceftriaxone, 2 g par jour en intraveineux pendant 14 à 21 jours. La prévention est basée essentiellement sur l'extraction d'une tique. Et vous voyez sur ces images la méthode avec laquelle doit être fait l'extraction de la tique.